

APPAREIL LOCOMOTEUR

Fiches QE Haute Fréquence — Rhumatologie · Traumatologie · MPR — Version 1

Cross-match : 700 QEs officielles (Mai 2017 → 2025) × Cours AIO (Rhumato 921 p. · Traumato 921 p. · MPR 480 p.)

Appareil Locomoteur — 14 sessions · colonne « Professeur » = discipline (noms non fournis)

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 700 QEs (14 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	RÉADAPTATION FONCTIONNELLE (MPR)	97 Q	MPR / Réadaptation
2	TRAUMATISMES DE LA HANCHE	39 Q	Traumatologie
3	ARTHROSE	33 Q	Rhumatologie
4	FRACTURE DU FÉMUR (DIAPHYSE & EXTRÉMITÉ DISTALE)	32 Q	Traumatologie
5	TRAUMATISMES DU GENOU	29 Q	Traumatologie
6	SPONDYLOARTHRITE (SpA)	28 Q	Rhumatologie
7	GOUTTE	25 Q	Rhumatologie
8	FRACTURE DE LA JAMBE (TIBIA-FIBULA)	25 Q	Traumatologie
9	FRACTURE DE L'AVANT-BRAS	24 Q	Traumatologie
10	POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PR)	23 Q	Rhumatologie
11	FRACTURE HUMÉRALE	21 Q	Traumatologie
12	MONOARTHRITE	21 Q	Rhumatologie
13	FRACTURES ET LUXATIONS DE LA MAIN	20 Q	Traumatologie
14	INFECTIONS EN TRAUMATOLOGIE (MAIN & TISSUS MOUS)	20 Q	Traumatologie
15	TRAUMATISME DU COUDE	19 Q	Traumatologie
16	HYPERCALCÉMIE & HYPERPARATHYROIDIE	16 Q	Rhumatologie
17	ÉPAULE DOULOUREUSE (NON TRAUMATIQUE)	16 Q	Rhumatologie
18	SYNDROME DU CANAL CARPIEN	15 Q	Rhumatologie
19	TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE	15 Q	Traumatologie
20	PATHOLOGIES ABARTICULAIRES (PÉRI-ARTICULAIRES)	15 Q	Rhumatologie
21	RADICULALGIES (NCB & LOMBO-RADICULALGIES)	14 Q	Rhumatologie
22	TRAUMATISMES DE L'ÉPAULE (LUXATIONS)	13 Q	Traumatologie
23	TRAUMATISMES DU BASSIN	13 Q	Traumatologie
24	OSTÉOMALACIE	13 Q	Rhumatologie

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
25	PLAIES DE LA MAIN	13 Q	Traumatologie
26	TRAUMATISMES DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES	13 Q	Traumatologie
27	HANCHE DOULOUREUSE (COXITES & ÉTIOLOGIES)	11 Q	Rhumatologie
28	TUMEURS OSSEUSES	10 Q	Rhumatologie
29	ALGONEURODYSTROPHIE (SDRC TYPE I)	9 Q	Rhumatologie
30	OSTÉOPOROSE	9 Q	Rhumatologie
31	LOMBALGIES	9 Q	Rhumatologie
32	TUBERCULOSE OSTÉOARTICULAIRE (MAL DE POTT)	8 Q	Rhumatologie
33	TUMEURS DES PARTIES MOLLES	7 Q	Rhumatologie
34	RHUMATISME INFLAMMATOIRE (DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE)	7 Q	Rhumatologie
35	DIVERS — QUESTIONS TRANSVERSALES	7 Q	Transversal
36	FRACTURE DU POIGNET (EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DU RADIUS)	6 Q	Traumatologie
37	TRAUMATISME VASCULAIRE	5 Q	Traumatologie

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 14 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moylexam	% d'examen
RÉADAPTATION FONCTIONNELLE (MPR)	97	6.93	13.9%
TRAUMATISMES DE LA HANCHE	39	2.79	5.6%
ARTHROSE	33	2.36	4.7%
FRACTURE DU FÉMUR (DIAPHYSE & EXTRÉMITÉ DISTALE)	32	2.29	4.6%
TRAUMATISMES DU GENOU	29	2.07	4.1%
SPONDYLOARTHRITE (SpA)	28	2.00	4.0%
GOUTTE	25	1.79	3.6%
FRACTURE DE LA JAMBE (TIBIA-FIBULA)	25	1.79	3.6%
FRACTURE DE L'AVANT-BRAS	24	1.71	3.4%
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PR)	23	1.64	3.3%
FRACTURE HUMÉRALE	21	1.50	3.0%
MONOARTHRITE	21	1.50	3.0%
FRACTURES ET LUXATIONS DE LA MAIN	20	1.43	2.9%
INFECTIONS EN TRAUMATOLOGIE (MAIN & TISSUS MOUS)	20	1.43	2.9%
TRAUMATISME DU COUDE	19	1.36	2.7%
HYPERCALCÉMIE & HYPERPARATHYROIDIE	16	1.14	2.3%
ÉPAULE DOULOUREUSE (NON TRAUMATIQUE)	16	1.14	2.3%
SYNDROME DU CANAL CARPIEN	15	1.07	2.1%
TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE	15	1.07	2.1%
PATHOLOGIES ABARTICULAIRES (PÉRI-ARTICULAIRES)	15	1.07	2.1%
RADICULALGIES (NCB & LOMBO-RADICULALGIES)	14	1.00	2.0%
TRAUMATISMES DE L'ÉPAULE (LUXATIONS)	13	0.93	1.9%
TRAUMATISMES DU BASSIN	13	0.93	1.9%
OSTÉOMALACIE	13	0.93	1.9%
PLAIES DE LA MAIN	13	0.93	1.9%
TRAUMATISMES DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES	13	0.93	1.9%
HANCHE DOULOUREUSE (COXITES & ÉTIOLOGIES)	11	0.79	1.6%
TUMEURS OSSEUSES	10	0.71	1.4%
ALGONEURODYSTROPHIE (SDRC TYPE I)	9	0.64	1.3%
OSTÉOPOROSE	9	0.64	1.3%

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
LOMBALGIES	9	0.64	1.3%
TUBERCULOSE OSTÉOARTICULAIRE (MAL DE POTT)	8	0.57	1.1%
TUMEURS DES PARTIES MOLLES	7	0.50	1.0%
RHUMATISME INFLAMMATOIRE (DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE)	7	0.50	1.0%
DIVERS — QUESTIONS TRANSVERSALES	7	0.50	1.0%
FRACTURE DU POIGNET (EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DU RADIUS)	6	0.43	0.9%
TRAUMATISME VASCULAIRE	5	0.36	0.7%
TOTAL — programme Appareil Locomoteur (37 leçons)	700 Q	50.0	100%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] RÉADAPTATION FONCTIONNELLE (MPR)

MPR / Réadaptation • ~6.93 Q/examen (97 Q)

□ Modèle CIF (Classification Internationale du Fonctionnement, OMS)

La triade CIF — savoir classer déficience / limitation d'activité / restriction de participation (LE concept le plus testé) :

- Déficience = atteinte de la structure ou fonction au niveau de l'ORGANE : douleur, limitation articulaire, amyotrophie, œdème, fessum, contracture, raideur, faiblesse musculaire, épanchement.
- Limitation d'activité = au niveau de la PERSONNE : difficulté à marcher, à monter/descendre les escaliers, à la préhension, à écrire.
- Restriction de participation = au niveau SOCIÉTAL/des rôles sociaux : difficulté à faire ses courses, à promener son chien, à aller à la mosquée/au travail, à promener son enfant.
- Δ Δ « Épanchement / craquement / limitation articulaire » = DÉFICIENCES, jamais des restrictions de participation (piège répété à chaque session).
- Δ Δ « Ne pas pouvoir travailler / faire du sport » = restriction de participation, PAS une limitation d'activité.
- Δ Δ La PEC du handicap est bio-médico-sociale : elle tient toujours compte du mode de vie du patient (réadapter le patient ET la société).

□ Récurent ++ : N2025 Q22-23, Mai/Juin/Nov/Déc 2024 Q43-45, Mai2023 Q43-45 (≈12 sessions)

Les professionnels de rééducation — qui fait quoi :

- Kinésithérapeute = douleur, limitation/instabilité articulaire, rééducation motrice → le « complément de PEC » par défaut d'une pathologie ostéo-articulaire.
- Orthoprothésiste (et ergothérapeute) = confection d'orthèses/prothèses sur mesure, dont l'orthèse de poignet.
- Orthophoniste = troubles du langage oral et écrit, troubles de la déglutition ; agit sur prescription médicale ; pas seulement chez l'enfant.
- Psychomotricien = troubles d'apprentissage, fonctions cognitives, retard psychomoteur.
- Δ Δ Le PODOLOGUE ne fabrique JAMAIS les prothèses ni les orthèses du poignet (distracteur systématique).
- Δ Δ Pour une gonarthrose / coxarthrose / lombalgie / tendinopathie → on adresse au kinésithérapeute, pas à l'ergothérapeute/orthophoniste/podologue.

□ Quasi chaque session : Juin2024 Q50, Nov2024 Q49, Juin2022 Q49, Juin2021 Q48

Orthèse vs prothèse :

- Orthèse = appareillage de soutien/correction d'un segment existant (ex : corset = orthèse, portée 23h/24 jusqu'en fin de croissance dans la scoliose).
- Orthèses d'inactivité (de repos) : immobilisation/stabilisation, repos, posture.
- Prothèse = remplace un segment manquant : emboîture faite sur mesure, peut être interne ou externe, nécessite une rééducation adaptée, prescription spécialisée.
- Bonne orthèse de main : sur mesure, esthétique, réalisée dans les délais.
- Δ Δ Le corset est une ORTHÈSE, pas une prothèse, et n'est pas un appareillage de série.
- Δ Δ Orthèse « de série » et « sophistiquée » ne sont PAS des qualités d'une bonne orthèse de main.

□ N2025 Q21, Mai/Juin/Déc 2024 Q50, Mai2023 Q47

Renforcement musculaire — définitions à ne pas inverser :

- Isométrique = SANS déplacement articulaire (statique).
- Isotonique = AVEC déplacement articulaire.
- Concentrique = rapprochement des extrémités du muscle ; excentrique = éloignement des extrémités.
- Isocinétique = vitesse constante du mouvement, nécessite un appareil dédié.

- **⚠ ⚠ Le QCM type inverse systématiquement isométrique/isotonique et concentrique/excentrique.**

□ Juin2020 Q45

Lésions musculaires du sportif (PEC immédiate) :

- Muscles les plus touchés = muscles bi-articulaires : ischio-jambiers, quadriceps (droit fémoral), gastrocnémiens.
- Triade clinique : douleur à l'étirement + douleur à la palpation + impotence.
- PEC immédiate = protocole « glace » : froid, compression, décharge/repos, arrêt momentané du sport.
- Signes de gravité : craquement perçu, impotence fonctionnelle totale immédiate, œdème d'installation retardée.
- **⚠ ⚠ PAS d'AINS local immédiat sur le muscle (favorise le saignement) — piège répété.**
- **⚠ ⚠ Hématome / œdème / ecchymoses ne font PAS partie de la « triade classique » selon les corrigés.**

□ Nov2024 Q47, Juin2022 Q48, Mai/Juin/Déc 2024 Q47-49

Marche & démarches pathologiques :

- Marche normale = automatique, réflexe et volontaire ; acquise vers 12 mois ; jamais les deux pieds décollés simultanément (sinon = course).
- Démarche cérébelleuse = pas irréguliers + élargissement du polygone de sustentation (ataxie).
- Steppage = déficit des releveurs (nerf fibulaire) ; fauchage = hémiplégie spastique ; marche en salutation = atteinte de hanche (coxarthrose, coxite).
- Canne : à tenir du côté CONTROLATÉRAL à l'atteinte (hanche/genou douloureux à droite → canne à gauche) ; adapter la hauteur ; l'associer à la rééducation.
- **⚠ ⚠ La canne homolatérale est le piège classique : c'est toujours le côté controlatéral.**
- **⚠ ⚠ La marche n'est pas acquise à 18 mois (c'est ~12 mois).**

□ Mai2023 Q49, Juin2023 Q47/Q49, Juin2020 Q50

Paralysie cérébrale (IMC), spasticité, chutes, activité physique :

- Paralysie cérébrale = 1ère cause de handicap moteur de l'enfant ; lésion FIXE (non évolutive) sur un cerveau en maturation (immature) ; PEC multidisciplinaire ; peut mener au polyhandicap ; n'entraîne pas QUE des déficiences motrices.
- Spasticité : il ne faut pas TOUJOURS la traiter ; traitable par toxine botulique / chirurgie ; seul élément du syndrome pyramidal accessible au traitement ; témoigne d'une atteinte CENTRALE.
- Chute du sujet âgé : facteurs précipitants = fièvre, syncope, trouble du rythme, AVC ; facteurs intrinsèques/prédisposants = âge, baisse d'acuité visuelle, sédentarité.
- Activité physique : 3 R = Raisonnable, Raisonnée, Régulière ; ≥150 min/semaine ; diminue le risque d'AVC ; conseillée dans certains cancers ; bénéfiques même < 30 min.
- **⚠ ⚠ « Lésion sur cerveau mature » ou « évolutive » = FAUX pour la PC.**
- **⚠ ⚠ La spasticité n'est PAS une atteinte périphérique ; « il faut toujours la traiter » est FAUX.**
- **⚠ ⚠ L'âge avancé est un facteur prédisposant, PAS un facteur précipitant de chute.**

□ Mai/Nov/Déc 2024 Q48, Mai/Nov 2024 Q50, Mai2023 Q48/Q50, Mai2021 Q50

Évaluation & complications de décubitus :

- Goniomètre = mesure les amplitudes (déficiences ARTICULAIRES) ; échelle d'Ashworth (modifiée) = spasticité/tonus (déficiences MUSCULAIRES).
- Échelle spécifique = une fonction d'une maladie donnée ; échelle générique = indépendamment de la maladie ; évaluation écologique = en milieu réel.
- Douleur : EVA, échelle verbale simple, échelle numérique.
- Complications de décubitus de l'appareil locomoteur : rétraction musculaire, enraidissement articulaire, ostéoporose, perte de force.
- Kinébalnéothérapie : antalgique, facilite le mouvement en cas de paralysie, remise en charge précoce ; contre-indiquée si infection cutanée.
- **⚠ ⚠ Inversion classique : le goniomètre n'évalue pas le muscle, l'Ashworth n'évalue pas l'articulation.**
- **⚠ ⚠ L'encombrement bronchique est une complication respiratoire, PAS locomotrice ; la kinébalnéothérapie n'est pas de l'électrothérapie.**

□ N2025 Q24/Q28, Juin2020 Q43/Q47, Juin2021 Q46

[RANG 2] TRAUMATISMES DE LA HANCHE

Traumatologie • ~2.79 Q/examen (39 Q)

□ *Fracture du col : Garden (I–IV, travées) + Pauwels (angle du trait)*

Luxation postérieure de la hanche (la plus fréquente) :

- Mécanisme du tableau de bord (AVP) : choc axial sur le fémur, genou fléchi.
- Attitude vicieuse : membre RACCOURCI, en ADDUCTION et ROTATION INTERNE, légère flexion.
- Variétés : iliaque (haute) ou ischiatique (basse).
- C'est une URGENCE : réduction en urgence (idéalement < 6 h) pour limiter la nécrose.
- Lésions associées du « tableau de bord » : fracture de la patella, fracture de l'extrémité inférieure du fémur, luxation postérieure du genou.
- ⚠️ ⚠️ *Adduction-rotation INTERNE = postérieure ; abduction-rotation EXTERNE = antérieure (à ne pas confondre).*
- ⚠️ ⚠️ *Devant une luxation postérieure : on RÉDUIT en urgence — pas de TDM/IRM préalable, pas de simple traction au lit.*
- ⚠️ ⚠️ *Complications tardives : nécrose de la tête fémorale et coxarthrose (pas « instabilité » ni « paralysie du membre » au sens large).*

□ N2025 Q48 (sciatique), Mai/Déc2024 Q5, Nov2024 Q5-7, Mai2022 Q3-5

Fracture du COL du fémur (cervicale vraie) :

- Classification de GARDEN (basée sur les travées osseuses) : I = engrenée en coxa valga ; II = non déplacée ; III = déplacée en coxa vara (partielle) ; IV = déplacée complète — valeur PRONOSTIQUE et thérapeutique.
- Classification de PAUWELS = angle du trait par rapport à l'horizontale (plus l'angle est vertical, plus c'est instable).
- Complications majeures : nécrose de la tête fémorale (vascularisation précaire) et pseudarthrose.
- Traitement : sujet jeune ou Garden I-II → ostéosynthèse (vissage) ; sujet âgé déplacée (Garden III-IV) → arthroplastie (prothèse).
- But principal chez le sujet âgé = SAUVER LA VIE du patient (mortalité élevée).
- ⚠️ ⚠️ *Pauwels type 3 = le plus INSTABLE (pas le plus stable).*
- ⚠️ ⚠️ *Clinique : douleur du pli de l'aîne + massif trochantérien indolore → fracture du COL ; signe clinostatique (talon ne décolle pas du plan du lit).*

□ N2025 Q37, Mai/Juin/Nov/Déc 2024 Q3, Juin2023 Q2, Mai2018 Q34-35

Fractures TROCHANTÉRIENNES (massif trochantérien, extra-articulaires) :

- Sujet âgé ostéoporotique +++ ; os spongieux bien vascularisé → consolident bien.
- Pseudarthrose et nécrose RARES (à l'inverse du col).
- Gravité liée aux complications de DÉCUBITUS (mortalité).
- Traitement = ostéosynthèse à appui épiphysaire/céphalique (vis-plaque DHS, clou gamma) → verticalisation rapide.
- Objectifs : verticaliser vite, sauver la vie, éviter les complications de décubitus.
- ⚠️ ⚠️ *Pas de prothèse en règle, pas de traitement orthopédique seul (alitement prolongé).*
- ⚠️ ⚠️ *Ce qui engage le pronostic vital = le décubitus, pas le « caractère ouvert » de ces fractures.*

□ Juin2024 Q4/Q7, N2025 Q42, Mai2021 Q6, Juin2020 Q10-11

Fractures du cotyle (acétabulum) :

- Sujet jeune, haute énergie ; incidences radiologiques spéciales (obliques de Judet) + TDM indispensable.
- Classification de Judet-Letournel (10 types) ; peuvent s'associer à une luxation de hanche.
- Peuvent léser le nerf sciatique ; se compliquent de coxarthrose ; PEC multidisciplinaire.
- ⚠️ ⚠️ *La TDM n'est PAS « rarement indiquée » : elle est systématique.*

□ Nov2024 Q2, Juin2022 Q1, Juin2023 Q4

[RANG 3] ARTHROSE

Rhumatologie • ~2.36 Q/examen (33 Q)

Diagnostic — clinique et radiologie :

- Douleur MÉCANIQUE : à l'effort, calmée par le repos, pas de réveil nocturne ; pas de retentissement général.
- Les 4 signes radiologiques cardinaux : pincement LOCALISÉ de l'interligne, ostéocondensation sous-chondrale, ostéophytes marginaux, géodes sous-chondrales.
- Pas de syndrome inflammatoire (CRP normale) ; liquide articulaire MÉCANIQUE : < 1000–2000 GB/mm³, PNN < 50 %, stérile, sans cristaux.
- ⚠️ ⚠️ *Syndesmophytes = spondyloarthritis ; érosions = arthrites inflammatoires ; déminéralisation diffuse = ostéoporose/ostéomalacie — AUCUN n'est un signe d'arthrose.*
- ⚠️ ⚠️ *Une CRP élevée n'authentifie PAS une poussée congestive d'arthrose.*

□ N2025 Q13, Mai2024 Q40, Juin/Nov2024 Q35, Mai2017 Q8/Q14

Localisations & arthrose secondaire :

- Localisations primitives : IPD (nodules d'Heberden), trapézo-métacarpienne (rhizarthrose), genou, hanche, rachis.
- Arthrose secondaire : plus précoce, plus sévère, sujet jeune ; causes = dysplasie, incongruence, genu varum/valgum, coxa vara/plana, post-traumatique, post-arthrite, ménisectomie.
- Formes : gonarthrose fémoro-patellaire (douleur en descente d'escaliers), rhizarthrose (trapézo-métacarpienne), hallux rigidus (MTP1), lombarthrose (70 % des arthroses, canal lombaire rétréci).
- ⚠️ ⚠️ *L'OSTÉOPOROSE n'est PAS une cause d'arthrose (le piège le plus répété de la leçon).*
- ⚠️ ⚠️ *Cheville, coude et MCP ne sont PAS des localisations d'arthrose primitive.*

□ Nov2024 Q33-34, Juin2022 Q40, Juin2020 Q21-22, Mai2018 Q11-12

Coxarthrose (souvent à réponse unique) :

- Souvent en lien avec une anomalie architecturale (forme secondaire fréquente).
- Douleur mécanique inguinale / face antérieure de cuisse irradiant au genou ; boiterie d'esquive ; amyotrophie quadricipitale.
- Mauvaise corrélation radio-clinique ; pas de bilan inflammatoire systématique.
- ⚠️ ⚠️ *La hanche n'est pas la localisation préférentielle de l'arthrose (genou et main plus fréquents).*
- ⚠️ ⚠️ *Douleur « essentiellement nocturne » et « bonne corrélation radio-clinique » sont FAUX.*

□ Déc2024 Q40, Mai2022 Q40, Mai2021 Q44

Traitement :

- Antalgiques (paracétamol) au long cours possibles ; AINS en cures COURTES ; activité physique en dehors des poussées ; perte de poids.
- Viscosupplémentation (acide hyaluronique) dans la gonarthrose débutante à modérée ; infiltrations de corticoïdes ; prothèse si échec.
- Arthrose destructrice rapide : pincement > 50 %/an, douleur brutale intense, clichés répétés à ≥ 3 mois.
- ⚠️ ⚠️ *AINS « en continu/au long cours » et morphine ne sont PAS indiqués ; l'activité physique n'est pas contre-indiquée.*

□ N2025 Q14, Déc/Mai2022 Q41, Juin2021 Q33

[RANG 4] FRACTURE DU FÉMUR (DIAPHYSE & EXTRÉMITÉ DISTALE)

Traumatologie • ~2.29 Q/examen (32 Q)

Fracture de la DIAPHYSE fémorale :

- Sujet JEUNE, traumatisme à HAUTE énergie (AVP) ; URGENCE thérapeutique.

- Risque vital : choc HÉMORRAGIQUE (perte sanguine importante) + embolie graisseuse.
- Rechercher SYSTÉMATIQUEMENT une fracture du col fémoral associée (fracture étagée) → la traiter EN PREMIER.
- Traitement de choix = enclouage centro-médullaire (ECM), chirurgical.
- Déplacement : fragment proximal en flexion-abduction, fragment distal en adduction-flexion.
- ⚠️ ⚠️ *Le traitement orthopédique n'est PAS la méthode de choix chez l'adulte.*
- ⚠️ ⚠️ *La consolidation prend ~3 mois (pas « moins de 45 jours »).*

□ N2025 Q43, Mai2024 Q15, Juin/Nov/Déc2024 Q15-16, Juin2020 Q17-18

Embolie graisseuse & genou flottant :

- Embolie graisseuse (24-72 h, triade de Gurd) : détresse respiratoire/dyspnée, pétéchies cervico-thoraciques, troubles de la conscience.
- Genou flottant = fracture du fémur + fracture de jambe sur le même membre.
- Polytraumatisme = ≥ 2 lésions dont une menace le pronostic vital.
- Fracture de fatigue : IRM = examen le plus sensible (radiographie normale au début).
- ⚠️ ⚠️ *Prise de poids et abolition des poulx distaux ne font PAS partie de l'embolie graisseuse (l'abolition des poulx oriente vers une ischémie).*

□ Juin2020 Q19, Mai2018 Q37/Q42, Mai2017 Q35-39

Fractures de l'extrémité DISTALE (supracondyliennes, sus- et inter-condyliennes) :

- Les supracondyliennes sont les plus fréquentes ; peuvent léser le pédicule POPLITÉ.
- Sus- et inter-condylienne = fracture ARTICULAIRE → traitement chirurgical, risque de raideur et d'arthrose du genou.
- Bilan radiologique obligatoire : genou face + profil.
- ⚠️ ⚠️ *Ce ne sont pas des fractures « extra-articulaires » lorsqu'elles sont inter-condyliennes ; le traitement n'est pas « surtout orthopédique ».*

□ N2025 Q40, Mai/Juin/Nov2024 Q1, Juin2023 Q5, Mai2023 Q2

[RANG 5] TRAUMATISMES DU GENOU

Traumatologie • ~2.07 Q/examen (29 Q)

□ Plateau tibial : Schatzker (I–VI)

Entorses & lésions ligamentaires :

- LCA (pivot central) : test de Lachman (le plus sensible) + tiroir antérieur + gros genou (hémarthrose) ; mécanisme VALFE (valgus-flexion-rotation externe).
- LCP : AVALEMENT/recul de la TTA à l'inspection + tiroir postérieur ; mécanisme par choc direct antérieur (tableau de bord).
- LLI (collatéral médial) : laxité en VALGUS ; isolé → traitement fonctionnel.
- Entorse grave = atteinte du pivot central ; luxation du genou = stade ultime des dégâts ligamentaires.
- ⚠️ ⚠️ *L'avalement de la TTA = LCP, pas LCA. Le LCA ne cicatrise pas spontanément et ne se répare pas par suture en urgence.*
- ⚠️ ⚠️ *Devant une LUXATION du genou : rechercher impérativement une lésion de l'ARTÈRE POPLITÉE (urgence vasculaire) + nerf fibulaire.*

□ N2025 Q36, Mai2023 Q5-6, Juin2023 Q6, Mai2022 Q1-2, Mai2018 Q38

Lésions méniscales :

- Le ménisque INTERNE (médial) est le plus touché (plus fixe) ; souvent associé à une rupture du LCA (triade : LCA + LLI + ménisque interne).
- Diagnostic = IRM (pas l'échographie, pas la radio standard) ; tests : McMurray, Apley, Brunet-Guedj.
- Traitement : privilégier la conservation/suture méniscale ; méniscectomie économe si non réparable.
- ⚠️ ⚠️ *Le ménisque externe n'est pas le plus touché ; la méniscectomie systématique n'est pas le « traitement de choix ».*

□ N2025 Q39, Juin2023 Q3

Fractures de la patella & de Hoffa :

- Patella : mécanisme direct ou contraction violente du quadriceps ; diagnostic différentiel = rupture du tendon patellaire, patella bi/tripartita.
- Complications immédiates : nécrose cutanée, hémarthrose/arthritis, thrombophlébite ; tardives : raideur, arthrose fémoro-patellaire.
- Traitement orthopédique = fractures non déplacées avec appareil extenseur continu (rééducation nécessaire).
- Fracture de Hoffa = fracture unicondylienne fémorale à trait FRONTAL (coronal), articulaire, traitée par vissage ; passe inaperçue sur le cliché de face.
- ⚠️ La patella ne « consolide pas toujours en 3 mois » ; la luxation du genou et la fracture de Hoffa ne sont pas des diagnostics différentiels de la fracture de patella.

□ Mai/Juin/Nov/Déc 2024 Q2/Q7, Mai2023 Q1/Q3-4, Mai2017 Q29

[RANG 6] SPONDYLOARTHRITE (SpA)

Rhumatologie • ~2.00 Q/examen (28 Q)

Terrain & biologie :

- Sujet JEUNE, masculin ; associé au HLA-B27 (marqueur le plus spécifique) ; facteur rhumatoïde NÉGATIF, anti-CCP négatifs.
- Atteinte axiale (rachis, sacro-iliaque) + enthésique + périphérique des membres inférieurs.
- Famille = spondyloarthrites (englobe rhumatisme psoriasique, arthrites réactionnelles, MICI/Crohn).
- ⚠️ Association au HLA-B51 = Behçet, PAS la SpA. Facteur rhumatoïde et anti-CCP positifs orienteraient vers une PR.
- ⚠️ Arthrite septique et sarcoïdose n'appartiennent PAS au groupe des spondyloarthrites.

□ Mai2024 Q35, Juin2023 Q36, Mai/Juin2021 Q34-37, Juin2022 Q35

Signes radiographiques & tableau périphérique :

- Sacro-iliite, syndesmophytes, enthésite érosive, ossification des ligaments inter-vertébraux/inter-épineux, ankylose des articulations inter-apophysaires.
- Tableau périphérique typique : OLIGO-arthritis ASYMÉTRIQUE des membres inférieurs, touchant les grosses articulations (genoux, chevilles).
- Talalgie = enthésopathie calcanéenne (épine calcanéenne grossière), bilatérale, inflammatoire, évocatrice chez le sujet jeune.
- Syndrome pelvien : fessalgies bilatérales à bascule, pseudo-sciatique tronquée, test de Patrick positif.
- ⚠️ Syndesmophytes ≠ ostéophytes ; stries de Looser-Milkman = ostéomalacie, jamais SpA.
- ⚠️ Une polyarthrite bilatérale symétrique des petites articulations oriente vers une PR, pas vers une SpA périphérique.

□ Déc2024 Q39, Mai/Juin2022 Q33-34, Juin2023 Q34, Mai2018 Q13

Manifestations extra-articulaires & traitement :

- Extra-articulaires : uvéite ANTÉRIEURE aiguë, insuffisance aortique/troubles de conduction, amylose AA, ostéoporose, fibrose apicale, psoriasis, MICI.
- Traitement : AINS = 1ère ligne et test thérapeutique (efficacité rapide) ; biothérapies anti-TNFα (infliximab, adalimumab, certolizumab) et anti-IL-17 (sécukinumab) après échec.
- Indication de biothérapie : échec d'au moins 3 AINS sur 3 mois (formes axiales) / échec du méthotrexate-salazopyrine (formes périphériques).
- ⚠️ L'uvéite de la SpA est ANTÉRIEURE (pas postérieure). Rituximab et anti-IL-6 (tocilizumab) ne sont PAS indiqués dans la SpA.

□ Mai2024 Q36, Mai2023 Q37, Juin2023 Q35, Mai2017 Q16

[RANG 7] GOUTTE

Rhumatologie • ~1.79 Q/examen (25 Q)

Crise aiguë & diagnostic :

- Maladie microcristalline = dépôts de cristaux d'urate monosodique (en aiguilles, biréfringence négative).
- Crise : douleur BRUTALE, nocturne, insomnante, sur la MTP1 (gros orteil) ++, impotence, guérison spontanée, réponse spectaculaire à la colchicine.
- Liquide articulaire INFLAMMATOIRE (toujours faire une bactériologie pour éliminer une arthrite septique associée).
- Hyperuricémie = acide urique > 70 mg/L ; peut être normale pendant la crise.
- ⚠️ ⚠️ Une uricémie normale n'élimine PAS une crise de goutte ; l'hyperuricémie n'est pas synonyme de goutte (souvent asymptomatique).
- ⚠️ ⚠️ Les lithiases d'acide urique sont RADIOTRANSSPARENTES (non visibles sur radio standard).

□ N2025 Q11, Mai2024 Q41, Déc/Mai2022 Q42, Mai2017 Q13

Tophus, goutte secondaire & comorbidités :

- Tophus = dépôts uratiques péri-articulaires, contenu crayeux ; sièges : pavillon de l'oreille, rétro-olécrânien, tendon d'Achille ; régresse sous traitement de fond ; apparaît après plusieurs années.
- Goutte secondaire : IRC, diurétiques, aspirine à faible dose, chimiothérapie/lyse, polyglobulie, psoriasis, pyrazinamide, éthambutol.
- Associée au syndrome métabolique : obésité, HTA, diabète, dyslipidémie.
- ⚠️ ⚠️ Cloison nasale et ombilic ne sont PAS des sièges de tophus ; le tophus n'apparaît pas la 1ère année.
- ⚠️ ⚠️ Salazopyrine et méthotrexate ne donnent pas de goutte ; la dépression n'est pas une comorbidité de la goutte.

□ Mai2021 Q41, Juin2024 Q34, Mai2024 Q42, Juin2020 Q24

Traitement hypo-uricémiant (allopurinol) :

- Allopurinol = inhibiteur de la xanthine oxydase, 1ère intention, à VIE, dose PROGRESSIVE, cible uricémie < 360 µmol/L (< 60 mg/L).
- Associé à la colchicine en prophylaxie au début (~6 mois) pour éviter les crises de mobilisation.
- À éviter/adapter en cas d'insuffisance rénale sévère (DFG < 30) ; risque d'allergie cutanée grave (Lyell/DRESS).
- Vise à retarder l'atteinte rénale ; le choix dépend de la fonction rénale.
- ⚠️ ⚠️ Ne JAMAIS arrêter le traitement hypo-uricémiant pendant une crise ; dose initiale jamais maximale.
- ⚠️ ⚠️ Colchicine, corticoïdes, AINS, aspirine ne sont PAS hypo-uricémiants ; pas de contre-indication cardiaque à l'allopurinol.

□ N2025 Q12, Juin2024 Q33, Mai2023 Q38, Mai2021 Q40, Juin2020 Q26

[RANG 8] FRACTURE DE LA JAMBE (TIBIA-FIBULA)

Traumatologie • ~1.79 Q/examen (25 Q)

□ Fractures ouvertes : Cauchoux-Duparc (I–III) & Gustilo (I–IIIC)

Généralités & mécanisme :

- Les plus fréquentes des fractures des os longs ; ouverture cutanée FRÉQUENTE (tibia sous-cutané) ; traitement surtout CHIRURGICAL.
- Enclouage centro-médullaire = gold standard (fractures diaphysaires fermées).
- Mécanisme direct → trait transversal, même niveau tibia-fibula, haute énergie ; indirect (torsion) → trait spiroïde, niveaux différents, basse énergie.
- Une fracture de la malléole postérieure peut accompagner les fractures du tiers distal.
- ⚠️ ⚠️ Ce ne sont pas des fractures « rares » ; le traitement n'est pas « surtout orthopédique » ; l'ouverture cutanée n'est pas « exceptionnelle ».

□ N2025 Q44, Mai/Juin/Nov/Déc 2024 Q16-17, Déc2024 Q16

Fractures ouvertes & syndrome de loge :

- Cauchoix-Duparc : I = plaie punctiforme suturable sans tension ; II = berges contuses, risque de nécrose secondaire ; III = perte de substance/os à nu → fixateur externe.
- Gustilo : I < 1 cm ; II 1-10 cm ; IIIB > 10 cm nécessitant un lambeau de couverture ; IIIC = lésion artérielle nécessitant réparation vasculaire.
- Antibiothérapie dans les 3 premières heures = facteur clé de réduction du risque infectieux ; parage chirurgical essentiel.
- Le syndrome de loge PEUT survenir même sur une fracture OUVERTE (l'ouverture ne décomprime pas forcément) ; c'est une complication redoutable.
- ⚠️ *Ne pas confondre Gustilo IIIB (lambeau de couverture) et IIIC (réparation vasculaire) ; complications tardives = pseudarthrose (souvent septique), cal vicieux, retard de consolidation.*

□ N2025 Q44, Mai/Juin/Nov2024 Q17, Mai2021 Q17, Mai2018 Q40-41

Fractures du plateau tibial & du pilon :

- Plateau tibial (Schatzker) : type II = séparation-enfoncement du plateau latéral ; lésions élémentaires = séparation + enfoncement.
- Mécanisme direct → complications immédiates : phlyctènes, syndrome de loge, atteinte du pivot central.
- Pilon tibial = traumatisme axial à HAUTE énergie (chute de hauteur), articulaire.
- ⚠️ *Les PHLYCTÈNES en regard d'un plateau tibial CONTRE-INDIQUENT l'abord chirurgical (différer) ; elles ne traduisent ni syndrome de loge ni lésion vasculaire et n'autorisent pas la plaque vissée immédiate.*

□ N2025 Q41, Mai/Juin/Déc2024 Q4/Q6, Juin2021 Q6-7, Juin2022 Q21

[RANG 9] FRACTURE DE L'AVANT-BRAS

Traumatologie • ~1.71 Q/examen (24 Q)

Fractures des deux os de l'avant-bras :

- La fonction principale en jeu = la PRONOSUPINATION.
- Le déplacement dépend de la situation du trait par rapport aux muscles (court supinateur, rond pronateur).
- But du traitement : restituer la courbure pronatrice du radius (réduction anatomique, ostéosynthèse par plaque).
- Complications : pseudarthrose (non exceptionnelle), synostose radio-ulnaire, syndrome de loge (Volkmann).
- ⚠️ *Le cal vicieux ANGULAIRE est mal toléré (raideur grave de la pronosupination) ; le cal vicieux en baïonnette est mieux toléré.*
- ⚠️ *Pas d'ostéonécrose ni d'allongement du membre dans ces fractures.*

□ N2025 Q32, Nov/Déc2024 Q10-12, Mai/Juin2021 Q11-12, Juin2020 Q4

Extrémité distale du radius (Pouteau-Colles & variantes) :

- Femme ménopausée/ostéoporotique, chute sur la paume.
- Pouteau-Colles = déplacement POSTÉRIEUR → déformation en DOS DE FOURCHETTE (extra-articulaire).
- Goyrand-Smith = déplacement ANTÉRIEUR (ventre de fourchette).
- Enfant : motte de beurre (torus) ; décollement épiphysaire Salter-Harris type II = le plus fréquent.
- Traitement : non déplacée → orthopédique ; déplacée → chirurgie (embrochage de Kapandji).
- ⚠️ *Pouteau-Colles = dos de fourchette (postérieur), pas ventre de fourchette.*

□ Nov2024 Q14, Mai2023 Q11, Mai2021 Q13, Mai2022 Q13

Olécrane :

- Fracture ARTICULAIRE (interrompt l'appareil extenseur du coude), INSTABLE (traction du triceps).
- Traitement chirurgical (haubanage) si déplacée ; peut se compliquer de pseudarthrose.

□ N2025 Q32, Mai/Nov/Déc2024 Q11/Q13

[RANG 10] POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PR)

Rhumatologie • ~1.64 Q/examen (23 Q)

□ Critères ACR/EULAR 2010

Présentation clinique :

- Polyarthrite bilatérale, SYMÉTRIQUE, touchant MCP, IPP, MTP (mains, poignets, pieds).
- Dérouillage matinal > 30 min ; squeeze test positif (douleur à la compression transversale des MCP/MTP) ; gonflement ≥ 3 articulations.
- Aspect des doigts « en fuseau » au début ; évolution par poussées.
- ⚠ ⚠ La PR ÉPARGNE les IPD (leur atteinte oriente vers arthrose ou rhumatisme psoriasique).
- ⚠ ⚠ Un syndrome pelvien / des lombalgies inflammatoires orientent vers une SpA, pas une PR.

□ N2025 Q16, Mai2023 Q42, Juin2023 Q40, Mai2021 Q42

Phase de début & biologie :

- Phase de début : NON déformante, radios souvent normales (ou déminéralisation en bande) ; synovites visibles à l'échographie/IRM ; nodules rhumatoïdes rares.
- Anti-CCP (ACPA) = spécificité > 95 %, présents tôt, facteur de mauvais pronostic.
- Facteur rhumatoïde = non spécifique (sujets sains âgés, autres maladies) ; anticorps anti-ADN natif ABSENTS.
- Érosions marginales au contact de la synoviale ; déformations tardives : col de cygne, boutonnière, coup de vent cubital, dos de chameau.
- ⚠ ⚠ Au début, la PR n'est ni déformante ni érosive ; le FR n'est pas « constamment positif » ; anti-ADN natif et anti-nucléaires forts orienteraient vers un lupus.

□ Mai/Juin/Nov2024 Q37-40, Juin2021 Q37, Mai2018 Q17

Traitement :

- Méthotrexate = traitement de fond de 1ère intention (efficacité en 4-6 semaines) ; léflunomide ou sulfasalazine si contre-indication.
- Biothérapies (anti-TNFα...) en 2ème ligne ; corticothérapie d'attente à faible dose, à décroître rapidement.
- Anti-TNF et salazopyrine sont des traitements de fond.
- ⚠ ⚠ Le Zyloric (allopurinol) n'est PAS un traitement de la PR (c'est la goutte) ; les AINS ne se prescrivent pas « à vie » ; la biothérapie n'est pas utilisée d'emblée chez tout patient ; les corticoïdes ne sont pas un traitement de fond.

□ N2025 Q18, Mai/Juin/Nov/Déc2024 Q36/Q40, Juin2022 Q39

[RANG 11] FRACTURE HUMÉRALE

Traumatologie • ~1.50 Q/examen (21 Q)

Diaphyse humérale :

- Complication la plus fréquente = paralysie du NERF RADIAL (gouttière de torsion) → main tombante.
- Le plus souvent neurapraxie/élongation (récupération spontanée fréquente).
- ⚠ ⚠ Pas le médian, ni l'ulnaire, ni le circonflexe, ni le plexus : c'est le RADIAL pour la diaphyse.

□ N2025 Q29, Mai/Juin/Déc2024 Q8, Mai2023 Q8, Juin2022 Q13

Palette humérale (extrémité inférieure) & supracondylienne de l'enfant :

- Palette (sus- et inter-condylienne) = fracture ARTICULAIRE → mauvais pronostic, raideur du coude ; traitement chirurgical chez l'adulte ; repères du coude conservés.
- Supracondylienne de l'enfant : orthopédique si non déplacée (méthode de Blount), chirurgical (embrochage) si déplacée ; risque de syndrome de loge / Volkmann.
- ⚠ ⚠ La palette ne se complique pas de paralysie radiale (c'est la diaphyse) ; ne pas traiter une supracondylienne non déplacée par chirurgie d'emblée.

□ Nov/Déc2024 Q12-13, N2025 Q31, Mai2023 Q9-10

Extrémité supérieure (humérus proximal) :

- Sujet âgé surtout ; peut être à l'origine d'une nécrose de la tête humérale, d'une instabilité chronique, d'une raideur.
- Peut s'associer à une lésion du plexus brachial / du nerf axillaire (circonflexe).

□ Juin2020 Q16, Nov2024 Q20

[RANG 12] MONOARTHRITE

Rhumatologie • ~1.50 Q/examen (21 Q)

Monoarthrite chronique infectieuse :

- Germe le plus fréquent d'une monoarthrite chronique (genou, hanche/coxite) = la TUBERCULOSE (BK).
- Autres : syphilis, brucellose, mycoses.
- Une monoarthrite chronique avec dérouillage prolongé peut aussi relever d'une PR, d'une SpA ou d'une TB articulaire.
- ⚠️ ⚠️ *Staphylocoque, pneumocoque, BGN, streptocoque, gonocoque = germes des arthrites AIGUËS, pas de la monoarthrite chronique.*

□ Mai/Juin2024 Q23-24, Nov/Déc2024 Q24, Mai2023 Q24

Arthrite septique aiguë & analyse du liquide :

- Arthrite septique à germe banal : Staphylocoque doré = le plus fréquent.
- Cocci Gram POSITIF → staphylocoque ; Cocci Gram NÉGATIF → gonocoque (sujet jeune, IST).
- Définition = présence d'un GERME dans l'articulation ; liquide purulent ($> 50\,000\text{--}100\,000\text{ GB/mm}^3$, PNN $> 90\%$).
- Liquide inflammatoire = hypercellulaire ($> 2000\text{ GB}$), glucose abaissé ; mécanique = $< 1000\text{--}2000$, PNN $< 50\%$.
- ⚠️ ⚠️ *L'arthrite septique se définit par le germe, pas par un simple chiffre de leucocytes.*

□ Nov/Déc2024 Q23/Q25, Mai2021 Q25, Juin2020 Q31

Microcristaux, réactionnelles & Lyme :

- Chondrocalcinose = cristaux de pyrophosphate de calcium (rhomboédriques) ; goutte = cristaux d'urate (aiguilles).
- Arthrites réactionnelles : Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Chlamydia, Mycoplasme.
- Maladie de Lyme : Borrelia burgdorferi, transmise par tiques, érythème chronique migrant, méningo-radculite.
- Articulation déformée mais INDOLORE = arthropathie nerveuse (tabès, Charcot).
- ⚠️ ⚠️ *Le staphylocoque n'est pas un agent d'arthrite réactionnelle.*

□ Juin2022 Q23-24, Mai2021 Q39, Mai2023 Q25

[RANG 13] FRACTURES ET LUXATIONS DE LA MAIN

Traumatologie • ~1.43 Q/examen (20 Q)

Fracture du SCAPHOÏDE :

- La plus fréquente des fractures du carpe ; chute sur la paume ; douleur de la TABATIÈRE ANATOMIQUE.
- Radiographie initiale souvent NORMALE (refaire à J10-15, ou TDM/IRM) ; siège au col dans 70 %.
- Traitement orthopédique = plâtre brachio-antébrachio-palmaire prenant la colonne du pouce (plâtre de Verdan), ~90 jours.
- Complications : PSEUDARTHROSE et OSTÉONÉCROSE du pôle proximal (vascularisation rétrograde) → arthrose.
- ⚠️ ⚠️ *Pas de « dos de fourchette » (c'est Pouteau-Colles) ; n'est pas « toujours chirurgicale ».*

□ N2025 Q34, Mai/Juin/Déc2024 Q10/Q12, Mai2022 Q12, Mai2018 Q19-20

Base du 1er métacarpien & 5e métacarpien :

- Bennett = fracture-luxation articulaire de la base de M1 ; Rolando = fracture comminutive articulaire (Y/T) de la base de M1.
- Complication la plus redoutée = fermeture/rétraction de la 1ère commissure + rhizarthrose ; traitement = embrochage de Kapandji + ouverture de la commissure.
- Col du 5e métacarpien = fracture du BOXEUR ; complication = cal vicieux ROTATOIRE → clinodactylie ; chirurgie si angulation > 30°.
- **⚠ ⚠ La coxarthrose n'est pas une complication d'une fracture de la main (distracteur).**

□ N2025 Q50, Nov2024 Q22, Juin2023 Q22, Mai/Juin2020 Q5

Luxation péri-lunaire (rétro-lunaire) du carpe :

- Perte de contact entre le lunatum et le reste du carpe ; forme POSTÉRIEURE (rétro-lunaire) la plus fréquente.
- Souvent méconnue en urgence (clinique pauvre, « main plombée ») ; diagnostic surtout sur le cliché de PROFIL.
- Les lignes de GILULA ne sont plus parallèles sur la radio de face. URGENCE diagnostique et thérapeutique.

□ N2025 Q33, Mai2021 Q14, Mai2018 Q22

[RANG 14] INFECTIONS EN TRAUMATOLOGIE (MAIN & TISSUS MOUS)

Traumatologie • ~1.43 Q/examen (20 Q)

Panaris :

- Infection aiguë de la pulpe/péri-unguéale du doigt.
- Phase d'état / collectée : douleur LANCINANTE, INSOMNIANTE, pulsatile → traitement CHIRURGICAL (excision/mise à plat) + antibiothérapie.
- **⚠ ⚠ Une antibiothérapie seule, une simple incision, ou une amputation sont de mauvaises réponses ; au stade collecté c'est EXCISION + ATB.**

□ Mai/Juin2024 Q13, Nov/Déc2024 Q8/Q11, Mai2023 Q13

Phlegmons des gaines (ténosynovites infectieuses) :

- Atteinte de la gaine synoviale : doigt en crochet (semi-flexion antalgique), douleur du cul-de-sac proximal, douleur à l'extension.
- MAUVAIS pronostic et diffusion à l'AVANT-BRAS pour le phlegmon du POUCE (gaine radiale) et du 5e DOIGT (gaine ulnaire) — gaines communicantes (espace de Parona).
- Les doigts médians (2-3-4) ont des gaines indépendantes (meilleur pronostic).
- **⚠ ⚠ Le phlegmon « dorsal de la main » et celui des 3e/4e doigts ne diffusent pas à l'avant-bras.**

□ N2025 Q35, Mai/Juin2024 Q14, Nov2024 Q9, Mai2023 Q14

Fasciite nécrosante (dermo-hypodermite nécrosante) :

- URGENCE VITALE ; terrain diabétique/immunodéprimé ; douleur INTENSE disproportionnée avec une peau d'aspect quasi normal au début, puis placard ecchymo-nécrotique, choc, aggravation rapide.
- Traitement = excision chirurgicale LARGE des tissus nécrosés en urgence + antibiothérapie + réanimation ; complication redoutable = le DÉCÈS.
- **⚠ ⚠ Erreurs classiques (cas QE) : examen insuffisant, renvoi à domicile, prescription d'AINS (à éviter : ils masquent/aggravent).**

□ Juin2021 Q9-13, Mai2018 Q28, Mai2017 Q26

[RANG 15] TRAUMATISME DU COUDE

Traumatologie • ~1.36 Q/examen (19 Q)

□ Tête radiale : Mason

Luxation du coude & repères :

- 3 repères de surface : épicondyle, épitrochlée (épicondyle médial), olécrane → triangle (de Nélaton) en flexion.
- Luxation du coude : forme POSTÉRO-EXTERNE (postéro-latérale) la plus fréquente ; les repères anatomiques sont PERTURBÉS.
- Rechercher des lésions vasculo-nerveuses ; interposition de l'épitrochlée possible ; luxation invétérée = ancienne (> 3 semaines).
- ⚠ ⚠ Le coude n'est PAS la luxation la plus fréquente du squelette (c'est l'épaule) ; la luxation récidivante du coude est RARE.
- ⚠ ⚠ Dans la fracture supracondylienne les repères sont conservés ; dans la luxation ils sont perturbés.

□ N2025 Q30, Mai/Juin2024 Q9, Mai2022 Q8, Juin2020 Q1

Fractures de la tête radiale, de l'olécrane & Monteggia :

- Tête radiale : mécanisme indirect (chute sur la paume), classification de Mason, rééducation PRÉCOCE, complication tardive = raideur de la pronosupination ; pas toujours chirurgicale.
- Olécrane : 1ère fracture du coude, toujours articulaire, chirurgie (haubanage) si déplacée.
- Fracture-luxation de MONTEGGIA = fracture de l'ULNA + luxation de la tête RADIALE (≠ Galeazzi = radius + articulation radio-ulnaire distale).

□ Mai/Juin2024 Q10-11, Mai2022 Q10, Mai2018 Q26-27

[RANG 16] HYPERCALCÉMIE & HYPERPARATHYROÏDIE

Rhumatologie • ~1.14 Q/examen (16 Q)

Hyperparathyroïdie primaire (LE QCM le plus répété) :

- Lésion la plus fréquente = ADÉNOME parathyroïdien BÉNIN (≈ 80-85 %).
- Diagnostic souvent sur une hypercalcémie de découverte fortuite ; manifestations osseuses devenues rares ; l'adénome peut être ectopique.
- Traitement = exérèse chirurgicale si symptomatique (pas systématique).
- ⚠ ⚠ Ce n'est PAS un cancer parathyroïdien (< 1 %), ni une hyperplasie des 4 glandes (≈ 15 %), ni une tumeur hypophysaire — c'est l'ADÉNOME BÉNIN (item présent à quasi chaque session).

□ N2025 Q6, Mai/Juin/Nov/Déc2024 Q27-30, Mai/Juin2021-2022 (récurrent)

Étiologies & gravité de l'hypercalcémie :

- Deux grandes causes (> 90 %) : hyperparathyroïdie primaire et cancers/néoplasies (1ère cause si calcémie ≥ 3 mmol/L).
- Autres : sarcoïdose, myélome multiple, métastases, cancer bronchopulmonaire (PTHrp), intoxication à la vitamine D.
- Hypercalcémie MAJEURE = calcémie > 3,5 mmol/L (urgence) ; clinique : asthénie, polyurie-polydipsie, douleurs abdominales, constipation, troubles de conscience.
- ⚠ ⚠ L'OSTÉOMALACIE et l'hypovitaminose D donnent une HYPOcalcémie, jamais une hypercalcémie (piège récurrent).

□ Juin2023 Q28, Mai2021 Q33, Juin2024 Q32, Mai/Juin2022 Q29-30

[RANG 17] ÉPAULE DOULOUREUSE (NON TRAUMATIQUE)

Rhumatologie • ~1.14 Q/examen (16 Q)

□ Les 5 tableaux de De Sèze

Les tableaux cliniques (à relier au mécanisme) :

- Épaule douloureuse SIMPLE = tendinopathie/conflit sous-acromial de la coiffe.
- Épaule PSEUDO-PARALYTIQUE = rupture (transfixiante) des tendons de la coiffe des rotateurs.

- Épaule RAIDE / gelée = capsulite rétractile (terrain diabétique, limitation active ET passive, apyrexie).
- Épaule HYPERALGIQUE = tendinopathie calcifiante aiguë ; épaule INSTABLE = instabilité/luxation récidivante.
- ⚠ ⚠ La rupture de coiffe = pseudo-paralytique (pas « simple » ni « raide ») ; la capsulite = raide (pas pseudo-paralytique).

□ Mai/Juin/Nov/Déc2024 Q25-26, Mai2023 Q27, Mai2017 Q2-3

Les manœuvres (conflit vs tendons précis) :

- Conflit sous-acromial : manœuvres de NEER, HAWKINS, YOCUM.
- Jobe = sus-épineux (supra-épineux) ; Patte = sous-épineux (infra-épineux) ; lift-off/belly-press = sous-scapulaire ; palm-up = longue portion du biceps.
- ⚠ ⚠ La manœuvre de THOMPSON explore le tendon d'Achille — c'est un distracteur dans l'épaule.
- ⚠ ⚠ Jobe et Patte ne sont PAS des manœuvres de conflit sous-acromial.

□ Mai/Juin2024 Q24-25, Mai2021 Q27, Mai2018 Q2

[RANG 18] SYNDROME DU CANAL CARPIEN

Rhumatologie • ~1.07 Q/examen (15 Q)

Physiopathologie & clinique :

- Compression du nerf MÉDIAN au poignet (sous le rétinaculum des fléchisseurs).
- Femme +++ , péri-ménopause ; souvent BILATÉRAL ; souvent IDIOPATHIQUE (≈ 50 %) ; forme sensitive la plus fréquente.
- Paresthésies nocturnes des 3 premiers doigts (pouce, index, majeur) ; manœuvres de TINEL et de PHALEN positives.
- Étiologies secondaires : PR, hypothyroïdie, diabète, amylose, grossesse, acromégalie.
- ⚠ ⚠ Ce n'est PAS le nerf cubital/ulnaire (canal de Guyon) ni le nerf radial ; pas un spasme des artères digitales (Raynaud).
- ⚠ ⚠ L'amyotrophie de la loge HYPOthénar oriente vers le nerf ulnaire, pas le médian.

□ N2025 Q8, Mai/Juin/Nov/Déc2024 Q28-29, Mai2023 Q29, Juin2020 Q37

Diagnostic & traitement :

- EMG : confirme et précède la chirurgie ; peut être normal dans les formes débutantes.
- Forme légère idiopathique : orthèse nocturne, infiltration ; forme DÉFICITAIRE (amyotrophie thénarienne + déficit sensitif installé) → CHIRURGIE (neurolyse).
- ⚠ ⚠ Le traitement n'est pas « systématiquement chirurgical » ; mais devant des signes déficitaires (amyotrophie thénar + anesthésie), la chirurgie est indiquée d'emblée.

□ N2025 Q8, Mai2021 Q32, Mai2022 Q29, Mai2018 Q47

[RANG 19] TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE

Traumatologie • ~1.07 Q/examen (15 Q)

□ Fractures malléolaires : Danis-Weber (A/B/C)

Entorse de cheville :

- TRÈS fréquente ; mécanisme = INVERSION forcée ; 90 % touchent le ligament collatéral LATÉRAL (faisceau talo-fibulaire antérieur).
- Rééducation fonctionnelle ESSENTIELLE ; complication = instabilité chronique.
- Traitement d'urgence = protocole GREC/RICE : repos, glaçage, compression, immobilisation/élévation.
- Diagnostics d'élimination : fracture de la base du 5e métatarsien, fracture malléolaire, rupture du tendon calcanéen (impossibilité de se mettre sur la pointe du pied).
- ⚠ ⚠ Le mécanisme n'est pas une éversion ; ce n'est pas le ligament collatéral MÉDIAL (deltoïde) qui est touché à 90 % ; la rééducation n'est pas optionnelle ; pas de massages transverses en urgence.

□ N2025 Q45, Mai/Juin/Nov/Déc2024 Q15-18, Juin2022 Q22, Mai2021 Q18

Fractures malléolaires & Maisonneuve :

- Mécanisme ROTATIONNEL (pas haute énergie) ; classification de Danis-Weber selon le niveau du trait fibulaire par rapport à la syndesmo : A (sous-ligamentaire, adduction), B (inter-ligamentaire, rotation externe), C (sus-ligamentaire, abduction).
- Les radios dynamiques (rotation externe forcée) explorent le faisceau profond du ligament deltoïdien ; déplacement talaire = indication chirurgicale.
- Fracture de MAISONNEUVE = fracture de la malléole médiale + fracture PROXIMALE de la fibula (col) + lésion syndesmotique.
- Fracture du pilon tibial = traumatisme axial à haute énergie. Bimalléolaire → traitement chirurgical.
- ⚠ ⚠ *Le traitement orthopédique n'est pas suffisant pour une fracture bimalléolaire déplacée ; le diabétique fait surtout les complications.*

□ Déc2024 Q17, Mai2023 Q18, Mai2022 Q21, Mai2017 Q31-32

[RANG 20] PATHOLOGIES ABARTICULAIRES (PÉRI-ARTICULAIRES)

Rhumatologie • ~1.07 Q/examen (15 Q)

Tendinopathies & De Quervain :

- Cause habituelle des tendinopathies = MICRO-TRAUMATISMES répétés.
- Tendinopathie = douleur à la palpation + à l'étirement + à la contraction résistée (la triade) ; rupture si étirement > 8 %.
- Ténosynovite de DE QUERVAIN = tendons du pouce (court extenseur + long abducteur), bord radial ; test de FINKELSTEIN positif.
- ⚠ ⚠ *Infections, tumeurs et médicaments ne sont pas la cause « habituelle » des tendinopathies ; De Quervain n'intéresse pas les fléchisseurs et n'est pas réveillée par Thompson.*
- ⚠ ⚠ *La palpation d'un nodule intra-tendineux ne fait pas partie de la définition d'une tendinopathie.*

□ Juin2024 Q25, Nov/Déc2024 Q30, Mai2023 Q31, Juin2021 Q28

Osgood-Schlatter & kyste de Baker :

- Maladie d'Osgood-Schlatter = apophysite/fragmentation de l'insertion du tendon rotulien sur la tubérosité tibiale antérieure ; adolescent sportif (10-15 ans).
- Kyste de Baker = creux POPLITÉ (genou).
- Épicondylite latérale (tennis elbow) ; tendinopathie de la patte d'oie (genou interne) ; du moyen fessier (hanche).

□ Mai2022 Q26, Mai2017 Q7, Mai2018 Q7

[RANG 21] RADICULALGIES (NCB & LOMBO-RADICULALGIES)

Rhumatologie • ~1.00 Q/examen (14 Q)

Lombosciatique & lombocruralgie communes (topographie) :

- Sciatique L5 (hernie L4-L5) : douleur face postéro-externe → dos du pied → GROS orteil.
- Sciatique S1 (hernie L5-S1) : face postérieure → talon/plante → 5e orteil + abolition du réflexe ACHILLÉEN.
- Cruralgie L3 = face antérieure de cuisse ; L4 = face antéro-interne de jambe + abolition du réflexe ROTULIEN.
- Radiculalgie commune = mécanique, mono-radiculaire, due à une hernie discale.
- ⚠ ⚠ *Ne pas inverser L5 (gros orteil) et S1 (5e orteil).*

□ Mai2018 Q5-6, Mai2017 Q1, Mai2021 Q30, Juin2020 Q35

Néuralgie cervico-brachiale (NCB) & drapeaux rouges :

- NCB commune = hernie discale + syndrome rachidien (torticolis) ; topographie radiculaire : C6 (hernie C5-C6) → pouce + abolition du réflexe bicipital/stylo-radial ; C7 (hernie C6-C7) → médus + abolition du réflexe TRICIPITAL ; C8 (hernie C7-D1) → bord interne de l'avant-bras + 5e doigt.
- Radiculalgie SYMPTOMATIQUE (secondaire) : douleur inflammatoire, pluri-radiculaire, fièvre, AEG → évoquer une cause tumorale/infectieuse.
- ⚠️ ⚠️ La NCB commune est rarement tumorale ; une radiculalgie inflammatoire/fébrile/pluriradiculaire n'est PAS une forme commune.

□ N2025 Q9, Mai/Juin2024 Q28/Q37, Juin2022 Q32, Mai2021 Q29

[RANG 22] TRAUMATISMES DE L'ÉPAULE (LUXATIONS)

Traumatologie • ~0.93 Q/examen (13 Q)

Luxation gléno-humérale ANTÉRIEURE (la plus fréquente) :

- Attitude du bras en ABDUCTION + ROTATION EXTERNE, irréductible/élastique.
- Signe de l'ÉPAULETTE (saillie de l'acromion) + comblement/vacuité du sillon delto-pectoral.
- Lésions : capsulo-ligamentaires antérieures (Bankart), ligament gléno-huméral inférieur ; complication = lésion du nerf AXILLAIRE (circonflexe), récidive.
- ⚠️ ⚠️ L'atteinte des ligaments acromio-claviculaires/conoïde-trapézoïde = luxation acromio-claviculaire, pas gléno-humérale.

□ Juin2024 Q19, Mai2022 Q17, Juin2020 Q15

Luxation POSTÉRIEURE & acromio-claviculaire :

- Luxation postérieure (rare ; crise comitiale, électrisation) : attitude en ADDUCTION + ROTATION INTERNE ; signe fondamental = ROTATION EXTERNE IMPOSSIBLE.
- Radio = aspect en double contour de la tête humérale ; confirmation par TDM (tête en arrière de la glène) ; souvent méconnue.
- Luxation acromio-claviculaire stade III = rupture des ligaments acromio-claviculaires + coraco-claviculaires (conoïde + trapézoïde).

□ Mai/Déc2024 Q19/Q21, Mai/Juin2023 Q19, Juin2022 Q15, Mai2017 Q46

[RANG 23] TRAUMATISMES DU BASSIN

Traumatologie • ~0.93 Q/examen (13 Q)

□ Classification de Tile (A/B/C) ; cotyle = Judet-Letournel

Classification & disjonction « open book » :

- Tile : A = stable ; B = instabilité ROTATOIRE (dont B1 = « open book » par compression antéro-postérieure) ; C = instabilité VERTICALE complète (fracture de Voillemier, Malgaigne).
- « Open book » = lésion INSTABLE → URGENCE (pas de traitement différé) ; fixateur externe dans le cadre du Damage Control.
- Mécanismes directs : compression antéro-postérieure et compression latérale.
- ⚠️ ⚠️ Le type A n'est pas instable et ne menace pas le pronostic vital ; l'open book ne se traite pas en différé.

□ N2025 Q38, Mai/Juin/Déc2024 Q2-3, Mai2022 Q7, Mai2017 Q44

Complications & cotyle :

- Pronostic VITAL (hémorragie rétropéritonéale) ; complications vasculaires, neurologiques (plexus lombosacré/sciatique), urinaires (rupture de l'urètre MEMBRANEUX chez l'homme, rupture de vessie), cutanées ; impuissance sexuelle séquellaire.
- Toucher rectal SYSTÉMATIQUE.
- Fracture de l'acétabulum : classification de Judet-Letournel (10 types), incidences obliques de Judet ; peut léser le nerf sciatique ; complication = coxarthrose.

- **⚠ ⚠ C'est l'urètre MEMBRANEUX qui est lésé (pas prostatique) ; le sondage urinaire est contre-indiqué en urgence si suspicion de rupture urétrale ; incidences « inlet/outlet » pour l'anneau, pas pour le cotyle.**

□ Juin2023 Q1/Q4, Mai2021 Q8, Mai2018 Q48/Q50

[RANG 24] OSTÉOMALACIE

Rhumatologie • ~0.93 Q/examen (13 Q)

Définition & biologie :

- Défaut de MINÉRALISATION de la matrice (excès de tissu ostéoïde non minéralisé), par carence en vitamine D (< 10 ng/mL = carence).
- Biologie : calcémie BASSE, phosphorémie BASSE, calciurie basse, phosphatases alcalines ÉLEVÉES, 25-OH-vitamine D effondrée, PTH élevée (hyperparathyroïdie secondaire).
- Densité minérale osseuse basse.
- **⚠ ⚠ Phosphorémie « élevée » et PAL « basses » = FAUX ; calcémie et phosphorémie sont toutes deux BASSES.**

□ N2025 Q4-5, Mai/Nov/Déc2024 Q31, Mai2022 Q27, Mai2017 Q5

Radiologie & traitement :

- Signe radiologique pathognomonique = stries/fissures de LOOSER-MILKMAN (pseudo-fractures bilatérales) ; déminéralisation diffuse, déformations.
- Traitement = correction de l'hypovitaminose D (vitamine D ± calcium).
- Causes : carence d'apport/d'ensoleillement, malabsorption intestinale.
- **⚠ ⚠ Les bisphosphonates traitent l'OSTÉOPOROSE, pas l'ostéomalacie ; à différencier : l'ostéoporose a un bilan phosphocalcique NORMAL, l'ostéomalacie a une hypocalcémie/hypophosphorémie.**

□ N2025 Q4, Juin2023 Q30, Mai2018 Q9-10, Mai2023 Q32

[RANG 25] PLAIES DE LA MAIN

Traumatologie • ~0.93 Q/examen (13 Q)

Bilan systématique d'une plaie de la main/poignet :

- Tester chaque tendon, chaque nerf (sensibilité des deux bords/collatéraux), la vascularisation (recoloration capillaire).
- Plaie palmaire d'un doigt : fléchisseur PROFOND = flexion de P3 sur P2 ; fléchisseur SUPERFICIEL = flexion de P2 sur P1 ; sensibilité des deux bords.
- Plaie de la face ANTÉRIEURE du poignet : artère radiale/ulnaire, fléchisseurs du poignet, nerf médian (sensibilité de l'index, opposition du pouce), nerf ulnaire.
- **⚠ ⚠ Sur une plaie palmaire/antérieure, on ne teste pas l'EXTENSION (versant dorsal) ni l'abduction du pouce comme priorité.**

□ Mai2024 Q19, Juin/Nov2024 Q20-21, Juin2023 Q19, Mai2022 Q15

Déformations des doigts (sections de l'appareil extenseur) :

- Doigt en BOUTONNIÈRE = section de la bandelette MÉDIANE de l'appareil extenseur en zone III (regard de l'IPP).
- Doigt en MAILLET (mallet) = section de la bandelette terminale en zone I (insertion sur P3) → déficit d'extension de P3.
- **⚠ ⚠ Ne pas confondre boutonnière (bandelette médiane, zone III) et maillet (bandelette terminale, zone I).**

□ Mai2024 Q20, Juin2023 Q20

[RANG 26] TRAUMATISMES DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES

Traumatologie • ~0.93 Q/examen (13 Q)

□ Classification de Seddon

Classification de Seddon & topographie :

- NEURAPRAXIE = sidération nerveuse (bloc de conduction transitoire, récupération complète).
- AXONOTMÈSIS = interruption axonale, gaines conservées (récupération possible) ; NEUROTOMÈSIS = section complète nerf + gaines (chirurgie).
- Nerf RADIAL → main tombante (diaphyse humérale) ; nerf FIBULAIRE COMMUN → steppage + anesthésie face latérale de jambe/dos du pied (plaie face externe du genou) ; nerf ULNAIRE → griffe + anesthésie 5e doigt + signe du journal ; nerf TIBIAL → face plantaire.
- ⚠️ ⚠️ La neurapraxie n'est PAS une section : c'est une simple sidération.

□ Juin2021 Q18, Juin2022 Q16, Mai2023 Q20

Plexus brachial & facteurs pronostiques :

- Atteinte du plexus brachial (traction/étirement, AVP moto) : paralysie radiculaire supérieure C5-C6, inférieure C8-T1, ou totale C5-T1.
- Bilan : radio cervico-thoracique, IRM/myéloscanner (arrachement radiculaire), EMG à DISTANCE (≈ 3 semaines).
- Facteurs pronostiques d'une lésion nerveuse : âge, qualité de la réparation chirurgicale, tabac, diabète, lésions vasculaires associées.
- ⚠️ ⚠️ L'EMG n'est pas demandé « en urgence » (faussement normal au début).

□ Mai2017 Q48-50, Mai2018 Q45

[RANG 27] HANCHE DOULOUREUSE (COXITES & ÉTIOLOGIES)

Rhumatologie • ~0.79 Q/examen (11 Q)

Coxites (inflammatoires/infectieuses) vs étiologies mécaniques :

- Coxites chroniques : spondyloarthrite (++), tuberculose de la hanche, PR.
- Coxite aiguë : arthrite septique à pyogène.
- Étiologies MÉCANIQUES de la coxo-fémorale : coxarthrose, ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, algodystrophie de la hanche.
- ⚠️ ⚠️ Coxarthrose, ostéonécrose, algodystrophie et synovite villonodulaire ne sont PAS des « coxites ».
- ⚠️ ⚠️ La spondyloarthrite et la TB sont inflammatoires/infectieuses, pas mécaniques.

□ N2025 Q3, Mai/Juin2024 Q27, Mai2022 Q24, Juin2022 Q25, Mai2017 Q4/Q10

[RANG 28] TUMEURS OSSEUSES

Rhumatologie • ~0.71 Q/examen (10 Q)

Malignité : signes & démarche diagnostique :

- Signes radiologiques de MALIGNITÉ : ostéolyse mal limitée, corticale soufflée/rompue, apposition périostée en bulbe d'oignon (Ewing) ou éperon de Codman/feu d'herbe (ostéosarcome), envahissement des parties molles.
- Diagnostic = clinique + imagerie + confirmation ANATOMOPATHOLOGIQUE (biopsie réalisée APRÈS l'IRM) ; biopsie chirurgicale préférée.
- Circonstances : douleur résistante aux antalgiques, tuméfaction/syndrome de masse, fracture pathologique.
- ⚠️ ⚠️ Une radiographie standard normale n'élimine PAS une tumeur ; le bilan biologique n'est pas « essentiel » au diagnostic.

□ Mai2024 Q22, Mai2018 Q49, Mai2017 Q42-43

Tumeurs primitives & métastases :

- Tumeurs malignes primitives les plus fréquentes : ostéosarcome (jeune, produit de l'ostéoïde, métaphyse du genou), chondrosarcome, sarcome d'Ewing.
- Ostéosarcome : image mixte ostéocondensante/ostéolytique, IRM cherche les skip metastases, traitement = chimiothérapie + chirurgie (pas chirurgie seule).
- Cancers ostéophiles (métastases) : sein, prostate, poumon, rein, thyroïde.
- **⚠ ⚠ Calcifications « pop-corn » = tumeur cartilagineuse, pas tumeur à cellules géantes ; la chirurgie large seule ne suffit pas pour l'ostéosarcome.**

□ N2025 Q47, Mai2021 Q24, Juin2021 Q19-20

[RANG 29] ALGONEURODYSTROPHIE (SDRC TYPE I)

Rhumatologie • ~0.64 Q/examen (9 Q)

Phases cliniques & imagerie :

- Phase CHAUDE (pseudo-inflammatoire) : douleur régionale articulaire/péri-articulaire, troubles vasomoteurs, allodynie ; SANS syndrome inflammatoire biologique.
- Phase FROIDE (tardive) : rétractions capsulo-ligamentaires, troubles trophiques cutanés, raideur.
- Imagerie : scintigraphie = HYPERFIXATION précoce ; radio = déminéralisation MOUCHETÉE tardive, avec RESPECT de l'interligne articulaire.
- Facteur déclenchant : traumatisme (entorse, fracture), chirurgie.
- **⚠ ⚠ Une VS/CRP élevée ou une fièvre VONT CONTRE le diagnostic (orientent vers une cause septique) — piège récurrent.**
- **⚠ ⚠ Pas de pincement de l'interligne ni de condensation (≠ arthrite/arthrose).**

□ N2025 Q7, Nov/Déc2024 Q29, Mai2021 Q31, Juin2020 Q36

[RANG 30] OSTÉOPOROSE

Rhumatologie • ~0.64 Q/examen (9 Q)

□ Définition densitométrique OMS : T-score $\leq -2,5$ (DXA)

Définition & diagnostic :

- Examen de référence = OSTÉODENSITOMÉTRIE (DXA/absorptiométrie biphotonique).
- Définition densitométrique : T-score $\leq -2,5$ (ostéopénie entre -1 et -2,5 ; ostéoporose sévère si fracture associée).
- Maladie diffuse : densité basse, architecture altérée, mais MINÉRALISATION et bilan phosphocalcique NORMAUX.
- **⚠ ⚠ Ce n'est PAS l'IRM, le scanner, la radio standard ou la scintigraphie qui définissent l'ostéoporose.**
- **⚠ ⚠ Devant un tassement vertébral : éliminer une métastase/myélome, une hyperparathyroïdie, une ostéomalacie.**

□ N2025 Q10, Mai/Juin/Nov/Déc2024 Q31-32, Mai2018 Q8, Mai2021 Q34

Traitement :

- Bisphosphonates (1ère intention), calcium + vitamine D, prévention des chutes, activité physique.
- Facteurs : ménopause, âge, corticothérapie prolongée.
- **⚠ ⚠ Les CORTICOÏDES ne traitent pas l'ostéoporose : ils en sont une CAUSE (ostéoporose cortisonique).**

□ Mai2017 Q6, Juin2023 Q29

[RANG 31] LOMBALGIES

Rhumatologie • ~0.64 Q/examen (9 Q)

Lombalgie commune vs symptomatique (drapeaux rouges) :

- Lombalgie COMMUNE = mécanique (calmée par le repos), sans drapeau rouge ; forme la plus fréquente ; aiguë < 1 mois.
- Drapeaux rouges (lombalgie SYMPTOMATIQUE) : fièvre (spondylodiscite), antécédent de néoplasie (métastase), corticothérapie prolongée + sujet âgé (tassement), âge > 55 ans, douleur inflammatoire.
- Impulsivité à la toux → origine discale ; contracture paravertébrale + attitude antalgique.
- Une lombalgie peut révéler une pathologie viscérale (ulcère gastrique).
- *⚠ ⚠ Une douleur MÉCANIQUE est en faveur d'une lombalgie commune — c'est le seul item qui N'EST PAS un drapeau rouge (piège « sauf une » répété).*
- *⚠ ⚠ La forme symptomatique n'est pas la plus fréquente ; la radio n'est pas systématique.*

□ N2025 Q20, Mai2024 Q33, Juin/Nov2024 Q36/Q42, Juin2020 Q30

Imagerie & prise en charge :

- Pas d'imagerie d'emblée si lombalgie aiguë commune typique ; imagerie (radio/IRM) si drapeaux rouges ou chronicité.
- Maintien de l'activité (le repos strict n'est pas le meilleur traitement).
- *⚠ ⚠ L'IRM n'est PAS l'examen de 1ère intention de toute lombalgie aiguë ; le repos n'est pas « le meilleur traitement ».*

□ N2025 Q20, Déc2024 Q37, Mai2022 Q37

[RANG 32] TUBERCULOSE OSTÉOARTICULAIRE (MAL DE POTT)

Rhumatologie • ~0.57 Q/examen (8 Q)

Caractéristiques & topographie :

- Dissémination HÉMATOGÈNE du BK à partir d'un foyer viscéral primitif (pulmonaire).
- Mono-articulaire dans 90 % ; plurifocale chez l'immunodéprimé ; PAUCIBACILLAIRE (faible charge).
- Atteinte préférentielle du RACHIS (mal de Pott = spondylodiscite tuberculeuse = forme la plus fréquente), puis hanche/genou ; arthrite DESTRUCTRICE ; AEG inconstante, évolution insidieuse.
- *⚠ ⚠ Pas d'atteinte préférentielle des membres supérieurs ; l'arthrite est destructrice (pas « non destructrice »).*

□ N2025 Q19, Mai/Juin2024 Q34/Q42, Déc2024 Q34, Juin2021 Q40

Diagnostic :

- Signes radiographiques TARDIFS ; IRM = examen de référence pour l'extension.
- Absès froid (peut migrer/fistuliser) ; histologie = granulome épithélioïde et géantocellulaire avec NÉCROSE CASÉEUSE (confirme).

□ Mai2023 Q39, Déc2024 Q34

[RANG 33] TUMEURS DES PARTIES MOLLES

Rhumatologie • ~0.50 Q/examen (7 Q)

Démarche & tumeur glomique :

- Échographie = 1er examen d'une tuméfaction superficielle des parties molles (avant l'IRM).
- Tumeur GLOMIQUE : douleur du lit de l'ongle (sous-unguéale), spontanée, exacerbée par le FROID et la pression ; tache bleuâtre sous l'ongle ; diagnostic souvent méconnu/tardif ; IRM = masse sous-unguéale hypervascularisée ; traitement = exérèse en bloc.
- *⚠ ⚠ Ce n'est ni une exostose, ni une tumeur à cellules géantes, ni un lipome ; la radio n'est pas « toujours normale ».*

□ Juin/Déc2024 Q21-22, Mai2023 Q21-22, Mai2022 Q18

[RANG 34] RHUMATISME INFLAMMATOIRE (DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE)

Rhumatologie • ~0.50 Q/examen (7 Q)

Devant un rhumatisme inflammatoire débutant :

- Ponction articulaire SYSTÉMATIQUE en présence d'un épanchement ; cristaux de pyrophosphate de calcium → chondrocalcinose.
- Atteinte ACROMÉLIQUE (extrémités, mains/pieds) → PR ; aphtes bucco-génitaux → maladie de Behçet ; arthrite septique → PEC hospitalière obligatoire.
- Bilan minimal sans orientation : VS/CRP, facteur rhumatoïde, anti-CCP, anticorps antinucléaires.
- ⚠️ ⚠️ *Pas de marqueurs tumoraux dans le bilan minimal d'un rhumatisme inflammatoire débutant.*

□ Juin/Déc2024 Q41/Q33, Mai2022 Q33, Juin2022 Q42

Anticorps anti-CCP (ACPA) :

- Spécifiques de la PR (> 95 %), présents dès les premiers mois, facteur de MAUVAIS pronostic, intégrés aux critères ACR/EULAR.
- ⚠️ ⚠️ *Les anti-CCP ne se rencontrent PAS dans le lupus (item « sauf une » : c'est l'affirmation fausse).*

□ Nov2024 Q41, Juin2020 Q29

[RANG 35] DIVERS — QUESTIONS TRANSVERSALES

Transversal • ~0.50 Q/examen (7 Q)

Notions transversales récurrentes :

- Fracture de fatigue/stress : contraintes mécaniques répétées, bien explorée par l'IRM (radio normale au début), traitement le plus souvent orthopédique ; pas de traumatisme violent ni de déplacement.
- Crush syndrome (rhabdomyolyse) : hyperkaliémie, insuffisance rénale aiguë, hypovolémie, CIVD — engage le pronostic vital.
- Signes de gravité d'une lésion musculaire : craquement perçu, impotence fonctionnelle totale immédiate, œdème d'installation retardée.
- ⚠️ ⚠️ *L'insuffisance SURRÉNALIENNE ne fait pas partie du crush syndrome (item « sauf une »).*

□ Mai2021 Q3, Mai2018 Q46, Mai2017 Q33

[RANG 36] FRACTURE DU POIGNET (EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DU RADIUS)

Traumatologie • ~0.43 Q/examen (6 Q)

Pouteau-Colles & traitement orthopédique :

- Femme ménopausée/ostéoporose, chute sur la paume ; Pouteau-Colles = déformation en dos de fourchette + main botte radiale → horizontalisation/bascule de la ligne bi-styloïdienne.
- Lignes de Gilula normales (carpe intact) ; Gérard-Marchant = Pouteau-Colles + fracture de la styloïde ulnaire ; Goyrand-Smith = déplacement antérieur.
- Bilan : radio poignet face + profil ; repères = styloïdes radiale et ulnaire.
- ⚠️ ⚠️ *Sous plâtre circulaire, la complication redoutable = syndrome de loge / syndrome de Volkmann (+ déplacement secondaire, algodystrophie).*
- ⚠️ ⚠️ *La fracture du scaphoïde n'est pas une fracture de l'extrémité inférieure du radius (distracteur).*

□ Juin2022 Q8-12, Mai2018 Q24

[RANG 37] TRAUMATISME VASCULAIRE

Traumatologie • ~0.36 Q/examen (5 Q)

Urgence & pièges diagnostiques :

- URGENCE diagnostique ET thérapeutique ; pronostic VITAL (hémorragie) et fonctionnel (ischémie → amputation).
- Membres INFÉRIEURS plus touchés ; associations lésionnelles fréquentes ; peut survenir dans les traumatismes FERMÉS.
- Signes d'une plaie artérielle : hématome important, saignement en jet, abolition des pouls distaux.
- Ischémie aiguë complète = « 5 P » : douleur, pâleur, abolition des pouls, paralysie, paresthésies.
- ⚠️ ⚠️ *Un examen clinique normal / l'absence de signes d'hémorragie ou d'ischémie N'ÉLIMINE PAS le diagnostic (lésion intinale, thrombose secondaire).*
- ⚠️ ⚠️ *Une plaie artérielle « sèche » correspond à une rupture COMPLÈTE (rétraction-thrombose), pas partielle ; dans l'ischémie complète les pouls sont ABSENTS.*

□ Mai/Juin2023 Q15, Mai2022 Q22, Mai/Mai2021/2017 Q20/Q41

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS APPAREIL LOCOMOTEUR

** CLASSIFICATIONS & SCORES À CONNAÎTRE **

Fracture du col fémoral	Garden I–IV (travées) + Pauwels (angle du trait)
Fractures ouvertes de jambe	Cauchoux-Duparc I–III · Gustilo I–IIIC
Plateau tibial	Schatzker I–VI
Fractures malléolaires / cheville	Danis-Weber A / B / C
Anneau pelvien	Tile A / B / C (B1 = open book)
Cotyle (acétabulum)	Judet-Letournel (10 types)
Tête radiale	Mason
Lésions nerveuses	Seddon : neurapraxie / axonotmésis / neurotmésis
Épaule douloureuse	De Sèze : les 5 tableaux
Ostéoporose (DXA)	T-score $\leq -2,5$
Polyarthrite rhumatoïde	Critères ACR/EULAR 2010 (anti-CCP)
Fracture-luxation avant-bras	Monteggia (ulna) · Galeazzi (radius)

** SIGNES, TESTS & REPÈRES CLÉS (test → signification) **

Marqueur / Critère	Indication
Lachman / tiroir antérieur	Rupture du LCA
Avalement de la TTA / tiroir postérieur	Rupture du LCP
Neer / Hawkins / Yocum	Conflit sous-acromial
Jobe / Patte	Sus-épineux / sous-épineux
Tinel / Phalen	Canal carpien (nerf médian)
Finkelstein	Ténosynovite de De Quervain
Thompson	Tendon d'Achille (distracteur de l'épaule !)
Signe de l'épaulette	Luxation ANTÉRIEURE d'épaule
Rotation externe impossible	Luxation POSTÉRIEURE d'épaule
Dos de fourchette	Pouteau-Colles (radius distal)
Douleur de la tabatière anatomique	Fracture du scaphoïde
Stries de Looser-Milkman	Ostéomalacie
Syndesmophytes + sacro-iliite + HLA-B27	Spondyloarthrite
Pincement + ostéophytes + géodes + condensation	Arthrose (4 signes)
Cristaux en aiguille / rhomboédriques	Goutte (urate) / chondrocalcinose (PPC)
Triade de Gurd (dyspnée, pétéchies, confusion)	Embolie graisseuse
« 5 P » (douleur, pâleur, pouls abolis, paralysie, paresthésie)	Ischémie aiguë de membre

**** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS (haute rentabilité) ****

- **⚠ Ostéoporose n'est PAS une cause d'arthrose ; les corticoïdes CAUSENT l'ostéoporose (ce n'est pas un traitement).**
- **⚠ Ostéomalacie : Ca ET P bas, PAL hautes, stries de Looser ⇒ ≠ ostéoporose (bilan phosphocalcique normal).**
- **⚠ Hyperparathyroïdie primaire = adénome BÉNIN (≈ 80 %), jamais un cancer en 1ère intention.**
- **⚠ Hypercalcémie ≥ 3 mmol/L : penser cancer ; l'ostéomalacie donne une HYPOcalcémie.**
- **⚠ Goutte : une uricémie normale n'élimine pas la crise ; ne jamais arrêter l'allopurinol pendant la crise.**
- **⚠ Canal carpien = nerf médian ; canal de Guyon = nerf ulnaire.**
- **⚠ SpA = HLA-B27 (B51 = Behçet), uvéite antérieure, FR/anti-CCP négatifs.**
- **⚠ PR épargne les IPD ; anti-CCP spécifiques ($> 95\%$) et absents dans le lupus ; le Zyloric ne traite pas la PR.**
- **⚠ Luxation postérieure de hanche = adduction + rotation interne → réduction en urgence.**
- **⚠ Col fémoral = nécrose/pseudarthrose ; trochantérienne = risque de décubitus (consolide bien).**
- **⚠ Fracture de diaphyse fémorale : chercher une fracture du col associée et la traiter en premier.**
- **⚠ Phlyctènes sur un plateau tibial = CONTRE-INDICATION à l'abord chirurgical (différer).**
- **⚠ Syndrome de loge possible même sur fracture ouverte ; diagnostic clinique → aponévrotomie urgente.**
- **⚠ Diaphyse humérale → nerf radial ; palette humérale → raideur (fracture articulaire).**
- **⚠ Monteggia = ulna + tête radiale ; Galeazzi = radius + radio-ulnaire distale.**
- **⚠ Canne du côté CONTROLATÉRAL ; sciatique L5 → gros orteil, S1 → 5e orteil.**
- **⚠ Phlegmon du pouce et du 5e doigt → diffusion à l'avant-bras (mauvais pronostic).**
- **⚠ Thompson = tendon d'Achille (pas l'épaule, ni le canal carpien, ni De Quervain).**

**** RÉFLEXES & CONDUITES À TENIR (chaînes décisionnelles) ****

- Luxation postérieure de hanche → réduction en URGENCE (< 6 h) → surveiller nécrose / coxarthrose.
- Fracture de diaphyse fémorale → urgence + choc hémorragique → chercher fracture du col → enclouage centro-médullaire.
- Fracture du col fémoral : sujet âgé déplacée → arthroplastie ; jeune / Garden I-II → ostéosynthèse.
- Fracture ouverte de jambe → antibiothérapie < 3 h + parage ; stade III → fixateur externe.
- Plaie de la main → tester tendon + nerf (les deux bords) + vascularisation, systématiquement.
- Panaris collecté → excision chirurgicale + antibiothérapie (jamais antibiothérapie seule).
- Fasciite nécrosante → excision large URGENTE + antibiothérapie + réanimation (pas d'AINS).
- Goutte : crise → colchicine/AINS ; traitement de fond → allopurinol + colchicine ~6 mois, cible < 360 $\mu\text{mol/L}$, à vie.
- PR → méthotrexate en 1ère intention (effet 4-6 sem) ± corticothérapie d'attente brève.
- SpA → AINS (test thérapeutique) → anti-TNF α / anti-IL-17 après échec de 3 AINS.
- Suspicion de syndrome de loge sous plâtre → ablation immédiate du plâtre → aponévrotomie.

Généré par Claude.ai (Claude (Opus 4.8)) — Version 1

Cross-match 700 QEs officielles × Cours AIO (Rhumato 921 p. · Traumatologie 921 p. · MPR 480 p.)

Appareil Locomoteur — 14 sessions · colonne « Professeur » = discipline (noms non fournis)

Améliorations Version 1 :

- ✓ Cross-match des 700 QEs officielles (14 sessions) classées par fréquence réelle
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang (1 → 37), groupée par discipline (Rhumato / Traumatologie / MPR)
- ✓ Déduplication : un seul bloc par concept, avec faits (✓) et pièges (⚠) consolidés
- ✓ FAUX explicites (⚠) issus des distracteurs récurrents des corrigés officiels
- ✓ Aide-mémoire transversal : classifications, tests/signes, pièges, conduites à tenir

✓ Programme déduit des topics réellement tombés (aucune liste officielle de leçons fournie) — aucun topic hors-programme identifiable